

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSIQUIATRIA E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO**

TESE DE DOUTORADO

**Complexidade Clínica em Psiquiatria: Fatores Associados a Trajetórias Adversas
e à Estratificação de Risco**

Kyara Rodrigues de Aguiar

Orientador: Prof. Dr. Ives Cavalcante Passos

Porto Alegre, abril de 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSIQUIATRIA E CIÊNCIAS DO
COMPORTAMENTO

**Complexidade Clínica em Psiquiatria: Fatores Associados a Trajetórias Adversas
e à Estratificação de Risco**

Kyara Rodrigues de Aguiar

Orientador: Ives Cavalcante Passos

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento.

Porto Alegre, abril de 2026

CIP - Catalogação na Publicação

Rodrigues de Aguiar, Kyara
Complexidade Clínica em Psiquiatria: Fatores
Associados a Trajetórias Adversas e à Estratificação
de Risco / Kyara Rodrigues de Aguiar. -- 2026.
334 f.
Orientador: Ives Cavalcante Passos.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do
Comportamento, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Transtorno Bipolar. 2. Transtorno por Uso de
Cocaína. 3. Comportamento Suicida. 4. Revisão
Sistemática. 5. Estudo Multicêntrico. I. Cavalcante
Passos, Ives, orient. II. Título.

KYARA RODRIGUES DE AGUIAR

**Complexidade Clínica em Psiquiatria: Fatores Associados a Trajetórias Adversas
e à Estratificação de Risco**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento.

Aprovada em: 17/04/2026

BANCA EXAMINADORA:

Profa. Dra. Adriane Ribeiro Rosa

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Relatora

Prof. Dr. Ramiro de Freitas Xavier Reckziegel

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dra. Taiane de Azevedo Cardoso

Deakin University

Suplente:

Dra. Daniela Tusi Braga de Lima

Agradecimentos

Agradeço à minha família pelo incentivo e apoio ao longo de toda a minha formação. Aos meus amigos, em especial Ana Krolow, Laura Barzoni e Luisa Toralles, colegas de profissão que se tornaram grandes amigas, por acompanharem de perto meus processos, ouvirem meus embates e celebrarem cada conquista, sempre com incentivo, apoio e disponibilidade, especialmente nos momentos mais desafiadores. Ao meu namorado, Tomás Piltcher, por dividir a rotina comigo, pelos cuidados no dia a dia, nas pequenas e grandes coisas, e por estar presente, inclusive, nas tardes de trabalho aos finais de semana.

Ao meu orientador, Ives Cavalcante Passos, com quem aprendi muito sobre a importância do trabalho em equipe e da valorização dos diferentes saberes e contribuições que cada pessoa pode trazer para a pesquisa. Admiro especialmente o esforço ativo em cultivar e transmitir esses valores dentro do grupo. Ives, admiro tua curiosidade intelectual e tua disposição constante em revisar caminhos, questionar práticas e seguir aprendendo. Obrigada por me ensinar. Agradeço também a todos os professores e colegas que confiaram em mim para trabalhar lado a lado, tanto na ciência quanto na prática clínica.

Aos meus pacientes, por me ajudarem a me tornar uma pessoa mais sensível e curiosa, e por me ensinarem continuamente sobre os diferentes processos e tempos de maturação do pensar, do observar e do compreender. Muito do que aprendi sobre escuta e cuidado vem de vocês.

À Cláudia Grabinski, secretária do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, que, tenho certeza, acolhe de forma muito especial os alunos que passam pelo nosso programa. Tornas nossa caminhada mais leve, vibras com nossas conquistas e, como também já tive a oportunidade de vivenciar, nos confortas nos desafios e nos revezes do caminho. Obrigada, Cláudia.

Agradeço especialmente a Karen Jansen e Taiane Azevedo Cardoso, duas pesquisadoras que admiro profundamente pela inteligência, comprometimento e resiliência. Aprendo muito com vocês e tenho certeza de que continuarei aprendendo ao longo da minha trajetória. Obrigada por me ensinarem e, sobretudo, por fazerem isso com carinho.

Aos meus colegas, em especial Camila, Bruno, Augusto, Vanessa e Aline, com quem trabalhei lado a lado em inúmeros artigos, capítulos de livro e projetos. Compartilhamos viagens, o frio na barriga antes de apresentações desafiadoras, intensas

discussões científicas e momentos de recalculando a rota sempre que necessário. Vocês fazem com que esta etapa da minha vida seja lembrada com muito afeto e companheirismo.

Por fim, agradeço ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que financiou toda a minha trajetória acadêmica por meio de bolsas de pesquisa. Agradeço também ao Ministério da Saúde pelo financiamento de um dos projetos que integra esta tese, um projeto muito desejado e em cujo potencial de contribuir para avanços na área acredito profundamente. A todos os participantes de pesquisa, colegas pesquisadores e colaboradores que contribuíram e continuam contribuindo para a construção de uma ciência forte, comprometida com o avanço do conhecimento e com o fortalecimento da saúde mental no Brasil.

Abreviaturas e siglas

C-SSRS - Columbia–Suicide Severity Rating Scale

GBD - Global Burden of Disease

LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros

OMS - Organização Mundial da Saúde

OR - Odds Ratio

RISE - Estudo Multicêntrico Brasileiro de Estratificação do Risco de Suicídio

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SUMÁRIO

Resumo	9
Abstract	11
Apresentação	13
Introdução	17
Justificativa	20
Objetivos	21
Considerações éticas	23
Considerações finais	24
Referências	25
Anexo	27

Resumo

Os transtornos mentais estão entre as principais causas de incapacidade no mundo, sendo caracterizados por elevada heterogeneidade clínica e por trajetórias distintas de evolução. Entre os principais marcadores de maior complexidade clínica em psiquiatria, destacam-se as comorbidades psiquiátricas, especialmente os transtornos por uso de substâncias, bem como o comportamento suicida, um dos desfechos mais graves e desafiadores da área. No contexto do transtorno bipolar, a comorbidade com transtorno por uso de cocaína tem sido associada à não adesão ao tratamento farmacológico, a qual, por sua vez, se relaciona a desfechos adversos, como maior risco de comportamento suicida, aumento das taxas de hospitalização e menores taxas de remissão. No entanto, ainda existem lacunas importantes na literatura quanto à magnitude dessa associação e aos seus correlatos clínicos. Paralelamente, o comportamento suicida constitui um importante problema de saúde pública e um dos desfechos mais graves em psiquiatria. Apesar dos avanços na identificação de fatores de risco, a literatura ainda necessita de expansão, especialmente em países de baixa e média renda, bem como de abordagens mais integradas, que considerem simultaneamente dados clínicos, biológicos e determinantes sociais na compreensão desse fenômeno.

Diante desse cenário, esta tese teve como objetivo investigar fatores associados a trajetórias clínicas adversas em psiquiatria, com ênfase na comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína e no risco de comportamento suicida, além de promover a tradução do conhecimento científico para a prática clínica. Para isso, foram desenvolvidos três produtos principais. O primeiro consistiu em uma revisão sistemática com **meta-análise e meta-regressão** sobre a prevalência do transtorno por uso de cocaína em indivíduos com transtorno bipolar e seus correlatos clínicos. Foram incluídos 27 estudos, totalizando 615.881 indivíduos. Os resultados demonstraram que essa comorbidade é frequente, com prevalência de 10,94% em amostras psiquiátricas gerais, e 46,25% em populações com transtornos por uso de substâncias. Além disso, a síntese qualitativa indicou maior gravidade clínica nesses indivíduos, incluindo maior carga de sintomas afetivos, mais comorbidades psiquiátricas, maior uso de múltiplas substâncias e menor adesão ao tratamento. O segundo produto consistiu em um artigo metodológico descrevendo o desenvolvimento e a implementação do **Estudo Multicêntrico Brasileiro de Estratificação do Risco de Suicídio (RISE)**, um estudo longitudinal multicêntrico nacional envolvendo 12 centros distribuídos nas 5 macrorregiões do Brasil. Foram apresentados dados descritivos preliminares de 381 participantes, indicando que o risco

suicida se organiza como um gradiente clinicamente coerente, caracterizado por maior vulnerabilidade psicossocial nos níveis mais elevados de risco, além de heterogeneidade relevante entre diferentes contextos assistenciais e perfis populacionais. Também foi observada consistência entre as classificações da C-SSRS e a avaliação clínica especializada. Por fim, o terceiro produto corresponde ao livro clínico **Passo a passo para a vida: guia psicoterapêutico prático para lidar com o comportamento suicida**, desenvolvido com o objetivo de traduzir evidências científicas em estratégias aplicáveis à prática clínica e ao cotidiano dos pacientes. Dessa forma, ao integrar síntese sistemática da literatura, desenvolvimento de um estudo multicêntrico nacional e tradução do conhecimento para a prática clínica, esta tese contribui para uma compreensão mais abrangente da complexidade clínica em psiquiatria e para o aprimoramento de estratégias de identificação e manejo de indivíduos em maior risco de desfechos adversos.

Palavras-chave: transtorno bipolar; transtorno por uso de cocaína; comportamento suicida; risco de suicídio; psiquiatria; revisão sistemática; estudo multicêntrico.

Abstract

Mental disorders are among the leading causes of disability worldwide and are characterized by marked clinical heterogeneity and distinct illness trajectories. Among the main markers of greater clinical complexity in psychiatry are psychiatric comorbidities, especially substance use disorders, as well as suicidal behavior, one of the most severe and challenging outcomes in the field. In the context of bipolar disorder, comorbidity with cocaine use disorder has been associated with non-adherence to pharmacological treatment, which, in turn, is related to adverse outcomes such as increased risk of suicidal behavior, higher rates of hospitalization, and lower remission rates. However, important gaps remain in the literature regarding the magnitude of this association and its clinical correlates. At the same time, suicidal behavior constitutes an important public health problem and one of the most severe outcomes in psychiatry. Despite advances in the identification of risk factors, the literature still requires expansion, particularly in low- and middle-income countries, as well as more integrated approaches that simultaneously consider clinical, biological, and social determinants in the understanding of this phenomenon.

In this context, this thesis aimed to investigate factors associated with adverse clinical trajectories in psychiatry, with emphasis on the comorbidity between bipolar disorder and cocaine use disorder and on suicide risk, as well as to promote the translation of scientific knowledge into clinical practice. To this end, three main products were developed. The first consisted of a **systematic review with meta-analysis and meta-regression** on the prevalence of cocaine use disorder in individuals with bipolar disorder and its clinical correlates. A total of 27 studies were included, comprising 615,881 individuals. The results demonstrated that this comorbidity is frequent, with a prevalence of 10.94% in general psychiatric samples, and 46.25% in substance use disorder populations. In addition, the qualitative synthesis indicated greater clinical severity in these individuals, including higher burden of affective symptoms, more psychiatric comorbidities, greater polysubstance use, and lower treatment adherence. The second product consisted of a methodological article describing the development and implementation of the **Estudo Multicêntrico Brasileiro de Estratificação do Risco de Suicídio (RISE)**, a national multicenter longitudinal study involving 12 centers distributed across the five macroregions of Brazil. Preliminary descriptive data from 381 participants were presented, indicating that suicide risk is organized as a clinically coherent gradient, characterized by greater psychosocial vulnerability at higher risk

levels, as well as relevant heterogeneity across different care settings and population profiles. Consistency was also observed between C-SSRS classifications and expert clinical assessment. Finally, the third product corresponds to the clinical book ***Passo a passo para a vida: guia psicoterapêutico prático para lidar com o comportamento suicida***, developed with the aim of translating scientific evidence into strategies applicable to clinical practice and to patients' daily lives.

Thus, by integrating a systematic synthesis of the literature, the development of a national multicenter study, and the translation of knowledge into clinical practice, this thesis contributes to a more comprehensive understanding of clinical complexity in psychiatry and to the improvement of strategies for identifying and managing individuals at higher risk of adverse outcomes.

Keywords: bipolar disorder; cocaine use disorder; suicidal behavior; suicide risk; psychiatry; systematic review; multicenter study.

Apresentação

Esta tese, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem como objetivo investigar fatores associados a trajetórias clínicas adversas em psiquiatria, com ênfase na comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína, bem como no risco de comportamento suicida.

Os transtornos mentais estão entre as principais causas de incapacidade no mundo, sendo caracterizados por elevada heterogeneidade clínica e por trajetórias distintas de evolução (1-4). Nesse contexto, a presença de comorbidades psiquiátricas, especialmente os transtornos por uso de substâncias, representa um dos principais desafios para o manejo clínico, estando associada a maior complexidade, pior prognóstico e dificuldades no tratamento (5). Dentro desse cenário, a comorbidade entre transtorno por uso de cocaína e transtorno bipolar apresenta lacunas importantes na literatura. As estimativas de prevalência variam amplamente entre os estudos, dependendo dos critérios diagnósticos adotados e do tipo de amostra, oscilando entre 10% e 27% (6,7). Além disso, os correlatos clínicos associados a essa comorbidade permanecem descritos de forma fragmentada, sem uma síntese sistemática robusta que permita compreender sua real magnitude e impacto clínico.

Paralelamente, o comportamento suicida configura-se como um dos desfechos mais graves em psiquiatria e um importante problema de saúde pública. No Brasil, observa-se um aumento consistente nas taxas de suicídio. Entre 2011 e 2022, houve crescimento médio anual de 3,7% (8). Embora existam estratégias eficazes de prevenção, ainda persistem limitações relevantes na compreensão integrada dos fatores associados ao comportamento suicida, especialmente em populações clínicas e em países de média renda, que concentram 73% das mortes por suicídio (9).

Diante disso, a presente tese foi estruturada em três produtos principais, que abordam diferentes níveis de compreensão e manejo desses fenômenos.

O primeiro estudo: “***Prevalence and clinical correlates of Cocaine Use Disorder among patients diagnosed with Bipolar Disorder: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression***” (artigo original publicado na revista *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, fator de impacto: 7.9), consiste em uma revisão sistemática com meta-análise e meta-regressão que teve como objetivo estimar a prevalência do transtorno por uso de cocaína em indivíduos com transtorno bipolar, bem como descrever os correlatos clínicos associados a essa comorbidade. Foram incluídos 27 estudos,

totalizando 615.881 indivíduos. Os achados indicam que essa comorbidade é frequente, com prevalência de 10,94% em amostras psiquiátricas gerais, e 46,25% em populações com transtornos por uso de substâncias. A meta-regressão não identificou moderadores significativos, possivelmente em função do número limitado de estudos e da baixa variabilidade das covariáveis incluídas. Além disso, a elevada heterogeneidade observada entre os estudos sugere a influência de diferenças metodológicas e clínicas entre as amostras, reforçando a complexidade desse fenômeno e a necessidade de maior padronização nos estudos futuros.

Além disso, a síntese qualitativa indicou que indivíduos com essa comorbidade apresentam maior gravidade clínica, incluindo maior carga de sintomas afetivos, mais comorbidades psiquiátricas, maior uso de múltiplas substâncias e comportamentos de risco, além de menor adesão ao tratamento medicamentoso. No entanto, esses achados devem ser interpretados com cautela, uma vez que muitos estudos não controlaram adequadamente fatores de confusão relevantes, como número de episódios, duração da doença, gravidade do transtorno bipolar e características do uso de cocaína, além do predomínio de delineamentos transversais, que limitam inferências causais. Ainda assim, o conjunto das evidências reforça seu papel como marcador de pior prognóstico clínico.

O segundo estudo: “***Suicide Risk Stratification in Psychiatric Patients: Methodological Framework and Preliminary Findings from a Nationwide Multicenter Cohort in Brazil***” (artigo original submetido à revista *Journal of Psychiatric Research*, fator de impacto: 3.2), consiste em um artigo metodológico que descreve o desenvolvimento e a implementação do Estudo Multicêntrico Brasileiro de Estratificação do Risco de Suicídio (RISE), bem como apresenta dados descritivos da amostra preliminar coletada até julho de 2025, totalizando 381 participantes. O RISE foi concebido como um estudo multicêntrico longitudinal de abrangência nacional, envolvendo 12 centros distribuídos nas 5 macrorregiões do Brasil, com o objetivo de investigar o comportamento suicida em populações psiquiátricas em contextos clínicos reais.

O projeto foi estruturado a partir de três objetivos principais: (1) validar a *Columbia–Suicide Severity Rating Scale* (C-SSRS) na população brasileira; (2) identificar fatores de risco e proteção associados a tentativas de suicídio em indivíduos com transtornos mentais; e (3) desenvolver um modelo preditivo, baseado em técnicas de *machine learning*, capaz de estimar o risco de tentativa de suicídio nos primeiros 12 meses após atendimento em serviços psiquiátricos especializados. Para isso, foi

desenvolvido um protocolo estruturado de avaliação que integra dimensões clínicas, psicossociais e contextuais, permitindo uma abordagem abrangente do fenômeno. Um dos diferenciais centrais do estudo é a incorporação de um questionário estruturado voltado à investigação de determinantes sociais da saúde, incluindo variáveis relacionadas à educação, renda, moradia, acesso a serviços e condições de vida, além de instrumentos específicos para a população LGBT. A seleção dessas variáveis foi orientada por uma revisão da literatura sobre fatores de risco e proteção para o comportamento suicida, com ênfase na integração entre determinantes biológicos, clínicos e sociais.

No âmbito deste artigo, realizou-se a caracterização das variáveis sociodemográficas, clínicas e psicossociais da amostra por meio de análises descritivas estratificadas segundo diferentes dimensões do comportamento suicida e do contexto clínico. As análises incluíram a estratificação por presença de ideação e comportamento suicida ao longo da vida e por níveis de risco no último mês, conforme avaliados pela C-SSRS. Adicionalmente, as características da amostra foram descritas segundo o cenário clínico e os centros de pesquisa participantes, e foram examinadas medidas clínicas, funcionais e de uso de substâncias ao longo das avaliações de baseline e seguimento.

Os resultados indicam que o risco suicida se organiza como um gradiente clinicamente coerente, caracterizado por maior vulnerabilidade psicossocial nos níveis mais elevados de risco, e que essa vulnerabilidade varia de forma relevante entre diferentes contextos assistenciais e perfis populacionais. Por fim, foi avaliada a concordância entre as classificações da C-SSRS e a avaliação clínica especializada, tanto para a dimensão ao longo da vida quanto para o último mês, observando-se um padrão consistente de concordância entre as abordagens.

Por fim, o terceiro produto da tese é o livro clínico **Passo a passo para a vida: guia psicoterapêutico prático para lidar com o comportamento suicida**, em processo de publicação pela Editora Artmed. A obra foi desenvolvida com o objetivo de traduzir o conhecimento científico acumulado na área em um material acessível, estruturado e diretamente aplicável à prática clínica e ao cotidiano dos pacientes. Seu desenvolvimento foi orientado por dois princípios centrais, rigor científico e aplicabilidade prática, buscando transformar evidências da literatura e da experiência clínica em estratégias concretas para o manejo do comportamento suicida, em linguagem compreensível ao paciente.

Ao integrar uma síntese sistemática da literatura, o desenvolvimento de um estudo multicêntrico nacional e a tradução do conhecimento para a prática clínica, esta tese busca contribuir para uma compreensão mais abrangente da complexidade clínica em psiquiatria, bem como para o aprimoramento de estratégias de identificação e manejo de indivíduos em maior risco de desfechos adversos.

Introdução

Os transtornos mentais estão entre as principais causas de incapacidade no mundo, afetando aproximadamente uma em cada oito pessoas e sendo responsáveis por cerca de 14,6% de toda a incapacidade relacionada à saúde global (10). Essa elevada carga reflete não apenas sua alta prevalência, mas também seu impacto significativo no funcionamento, na qualidade de vida e nos desfechos a longo prazo.

Para além de sua relevância epidemiológica, um dos principais desafios da psiquiatria contemporânea reside na expressiva heterogeneidade clínica observada dentro das categorias diagnósticas. Indivíduos com o mesmo diagnóstico podem apresentar trajetórias substancialmente distintas ao longo do tempo, variando desde estabilidade clínica até recorrência de episódios, pior funcionamento e maior risco de desfechos adversos. Essa variabilidade tem sido consistentemente demonstrada em diferentes transtornos, incluindo depressão maior (11,2), esquizofrenia (3) e transtorno bipolar (4). Esses achados sugerem que as categorias diagnósticas, isoladamente, são insuficientes para explicar a diversidade de desfechos clínicos observados na prática.

Nesse contexto, a noção de complexidade clínica surge como um eixo central para a compreensão das trajetórias em psiquiatria. A complexidade clínica não se limita à presença de um diagnóstico, mas reflete a interação entre múltiplos fatores que influenciam o curso e o prognóstico dos transtornos mentais. Entre esses fatores, as comorbidades psiquiátricas ocupam um papel de destaque, sendo reconhecidas como um dos principais determinantes de maior gravidade clínica e pior evolução (12).

Os transtornos por uso de substâncias apresentam elevada comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, incluindo transtornos do humor, ansiedade e personalidade (10). No entanto, essa associação é particularmente robusta no contexto do transtorno bipolar, com aumento de aproximadamente 50% na chance de comorbidade ($OR \approx 1,5$) (10). Além disso, observa-se uma alta prevalência de uso de substâncias entre indivíduos com transtorno bipolar, especialmente álcool, mas também com cannabis e outras drogas ilícitas (13). Essa comorbidade pode ser compreendida como um marcador de maior complexidade clínica, estando consistentemente associada a piores desfechos, incluindo maior risco de comportamento suicida, menor adesão ao tratamento, pior qualidade de vida e maior prejuízo funcional (5).

Dentro desse conjunto de comorbidades, a presente tese foca especificamente no transtorno bipolar comórbido com transtorno por uso de cocaína. Esse recorte se justifica pela relevância clínica da cocaína, tanto em nível global quanto no contexto dos

transtornos psiquiátricos. Estima-se que aproximadamente 25 milhões de pessoas tenham utilizado cocaína em 2023, com aumento expressivo na última década, refletindo a expansão do mercado global dessa substância (14). No contexto clínico, essa relevância se expressa de forma particularmente acentuada no transtorno bipolar. A prevalência do transtorno por uso de cocaína em indivíduos com transtorno bipolar varia entre aproximadamente 10% e 27%, dependendo dos critérios diagnósticos e das populações avaliadas (6,7).

Além disso, indivíduos com transtorno bipolar e comorbidade com uso de cocaína apresentam cerca de 40% maior chance de não adesão ao tratamento medicamentoso, um elemento central para a estabilização clínica do transtorno (15). A não adesão, por sua vez, associa-se a piores desfechos clínicos, incluindo maior recorrência de episódios, aumento das taxas de hospitalização, maior risco de tentativa de suicídio, maiores custos de tratamento e menores taxas de remissão e recuperação (16).

Outro fator central na compreensão da complexidade clínica nos transtornos mentais é o comportamento suicida, um dos desfechos mais graves e desafiadores em psiquiatria. Estima-se que cerca de 90% dos casos de suicídio estejam associados à presença de transtornos mentais (17). Ainda assim, o risco de comportamento suicida não se distribui de forma homogênea entre os indivíduos. Mesmo dentro de populações clínicas, pacientes com diagnósticos semelhantes podem apresentar níveis substancialmente distintos de risco. Essa variabilidade reflete a influência de múltiplos fatores que interagem ao longo das trajetórias clínicas, reforçando a necessidade de abordagens que considerem a complexidade desses determinantes (18).

Ao analisar a literatura sobre comportamento suicida, observa-se uma limitação importante relacionada à sua distribuição geográfica. A maior parte das evidências disponíveis é derivada de países de alta renda, em contextos com sistemas de saúde, organização social e perfis populacionais específicos (19). Em contraste, a maior parte das mortes por suicídio ocorre em países de baixa e média renda, que concentram aproximadamente 73% dos casos globalmente (9). Esse descompasso entre onde o conhecimento é produzido e onde o fenômeno é mais prevalente limita a generalização dos achados para contextos como o brasileiro.

O modelo biopsicossocial proposto por Turecki e Brent (2019) compreende o comportamento suicida como resultado da interação dinâmica entre múltiplos fatores que se acumulam, se articulam e se modificam ao longo do tempo, modulando o risco individual. Nessa perspectiva, embora cerca de 90% dos casos de morte por suicídio

estejam associados à presença de transtornos mentais, esse desfecho não pode ser explicado de forma unidimensional, nem atribuído a um único fator de risco (17). Ao contrário, ele emerge da interação entre sintomas psiquiátricos, uso de substâncias, experiências adversas ao longo da vida e fatores sociais e estruturais (18).

Ao considerar a dimensão social, evidencia-se que os determinantes sociais da saúde mental não atuam apenas como contexto, mas como forças estruturantes que influenciam diretamente a distribuição, a ocorrência e a gravidade dos transtornos mentais na população (19). Condições como pobreza, desigualdade, violência e instabilidade social afetam a exposição a adversidades, o acesso a recursos de proteção e cuidado e as possibilidades de recuperação, configurando-se como componentes centrais na produção e manutenção do sofrimento psíquico. Esses determinantes operam em múltiplos níveis, desde fatores estruturais mais distais até experiências mais proximais no cotidiano dos indivíduos, e interagem ao longo do curso de vida, frequentemente em articulação com fatores biológicos e psicológicos. Além disso, sua relação com os transtornos mentais é bidirecional: contextos sociais adversos aumentam o risco de adoecimento, ao passo que os próprios transtornos podem comprometer inserção social, renda e funcionalidade, aprofundando condições de vulnerabilidade (19).

A partir desse conjunto de evidências, evidenciam-se lacunas relevantes que fundamentam a presente tese. No contexto do transtorno bipolar comórbido com transtorno por uso de cocaína, observa-se não apenas uma ampla variação nas estimativas de prevalência entre os estudos, mas também uma descrição ainda fragmentada dos desfechos associados, sem uma síntese sistemática e integrada na literatura. No campo do comportamento suicida, embora diversos fatores de risco tenham sido identificados, estes ainda são frequentemente investigados de forma isolada, com limitada integração entre determinantes sociais, clínicos e biológicos. Além disso, há escassez de estudos longitudinais multicêntricos conduzidos em países de baixa e média renda, o que restringe a compreensão do fenômeno em contextos mais amplos e diversos.

Diante desse cenário, a presente tese tem como objetivo investigar fatores associados a trajetórias clínicas adversas em psiquiatria, com ênfase na comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína e no risco de comportamento suicida. Adicionalmente, busca-se promover a tradução do conhecimento científico sobre comportamento suicida para a prática clínica, contribuindo para a integração entre evidência e cuidado em saúde mental.

Justificativa

A elevada heterogeneidade clínica dos transtornos mentais e a existência de trajetórias distintas de evolução têm se consolidado como um dos principais desafios da psiquiatria contemporânea, com repercussões diretas na compreensão do prognóstico e no manejo clínico dos pacientes. Nesse contexto, a presença de comorbidades psiquiátricas, especialmente a comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína, tem sido reconhecida como um importante marcador de maior complexidade clínica, estando associada a pior evolução da doença. Apesar de sua relevância, as evidências disponíveis ainda são heterogêneas e fragmentadas, com variações substanciais nas estimativas de prevalência e limitações na caracterização integrada de seus correlatos clínicos. Paralelamente, o comportamento suicida permanece como um importante problema de saúde pública, cuja compreensão ainda é limitada por abordagens que frequentemente investigam fatores de risco de forma isolada, especialmente em contextos de países de média e baixa renda, onde se concentra a maior parte dos casos.

Diante desse cenário, torna-se necessária a adoção de abordagens mais integradas e metodologicamente robustas, que permitam compreender a complexidade dos determinantes associados a trajetórias clínicas adversas em psiquiatria, bem como avançar na identificação e no manejo de indivíduos em maior risco. Assim, a presente tese foi estruturada em três eixos complementares: inicialmente, uma síntese sistemática da literatura, com o objetivo de estimar a prevalência e caracterizar os correlatos clínicos da comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína; em seguida, a descrição do desenvolvimento e da implementação de uma coorte multicêntrica longitudinal nacional (RISE), por meio de um artigo metodológico voltado à padronização de procedimentos, caracterização da amostra e estruturação de estratégias para investigação do risco de comportamento suicida em contextos clínicos reais; e, por fim, a tradução do conhecimento científico para a prática clínica, por meio da elaboração de um guia psicoterapêutico voltado ao manejo do comportamento suicida. Dessa forma, esta tese busca contribuir para uma compreensão mais abrangente da complexidade clínica em psiquiatria, bem como para o aprimoramento de estratégias de identificação e intervenção em populações de maior risco.

Objetivos

Objetivo geral

Investigar fatores associados a trajetórias clínicas adversas em psiquiatria, com ênfase na comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína e no risco de comportamento suicida, e promover a tradução do conhecimento científico sobre comportamento suicida para a prática clínica.

Objetivos específicos

Prevalence and clinical correlates of cocaine use disorder among patients diagnosed with bipolar disorder: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression

1. Estimar a prevalência do transtorno por uso de cocaína em indivíduos com transtorno bipolar, incluindo a comparação entre amostras clínicas e populacionais.
2. Estimar a prevalência do transtorno por uso de cocaína de acordo com diferentes definições diagnósticas, incluindo uso atual e ao longo da vida, bem como padrões de abuso.
3. Examinar a prevalência do transtorno por uso de cocaína em subgrupos específicos, incluindo indivíduos com comorbidade com outros transtornos por uso de substâncias e de acordo com o subtipo de transtorno bipolar (tipo I e tipo II).
4. Avaliar a heterogeneidade entre os estudos por meio da estatística Q de Cochran, da estatística I^2 e de análises de meta-regressão.
5. Avaliar o viés de publicação e a robustez das estimativas por meio da inspeção de funnel plot, do teste de Egger, do método trim-and-fill e de análises de sensibilidade leave-one-out.
6. Sintetizar os correlatos clínicos associados à comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína.

Suicide Risk Stratification in Psychiatric Patients: Methodological Framework and Preliminary Findings from a Nationwide Multicenter Cohort in Brazil

1. Descrever o desenho metodológico, a estrutura multicêntrica e os procedimentos de coleta de dados do Estudo Multicêntrico Brasileiro de Estratificação do Risco de Suicídio.
2. Caracterizar a amostra quanto às variáveis sociodemográficas, clínicas e psicossociais.
3. Descrever e comparar as características da amostra de acordo com os níveis de ideação e comportamento suicida, conforme avaliados pela Columbia–Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS), considerando os períodos ao longo da vida e no último mês.
4. Descrever as características da amostra segundo o contexto clínico e o centro de pesquisa.
5. Descrever as medidas clínicas, funcionais e de uso de substâncias coletadas nos momentos de baseline e follow-up.
6. Avaliar a concordância entre a C-SSRS e a avaliação clínica especializada na identificação do risco de comportamento suicida.

Passo a passo para vida: Guia psicoterapêutico prático para lidar com o comportamento suicida.

1. Desenvolver um guia prático para o manejo do comportamento suicida, fundamentado em evidências científicas.
2. Promover a aplicabilidade clínica das estratégias propostas, aliada à acessibilidade do conteúdo para o público leigo.

Considerações éticas

O estudo multicêntrico que compõe esta tese, intitulado “Estratificação objetiva do risco de tentar suicídio na população brasileira: um estudo multicêntrico e prospectivo”, foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), instituição coordenadora do estudo, sob CAAE nº 76135223.4.1001.5327 e parecer consubstanciado nº 6.609.929, em conformidade com as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil.

Por tratar-se de um estudo multicêntrico nacional, envolvendo serviços de saúde mental distribuídos nas diferentes macrorregiões do Brasil, o projeto também foi submetido à apreciação e aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa das instituições participantes, conforme as exigências da Plataforma Brasil e das normativas nacionais para pesquisas envolvendo seres humanos.

Todos os participantes foram incluídos na pesquisa somente após a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por escrito, após receberem informações detalhadas sobre os objetivos do estudo, os procedimentos de coleta de dados e os potenciais riscos e benefícios associados à participação. Para as avaliações realizadas por telefone, foi elaborado um roteiro específico baseado nas orientações do Comitê de Ética em Pesquisa.

Foram adotadas medidas rigorosas de curadoria e governança de dados, incluindo políticas de restrição de acesso às bases de dados, anonimização das informações e procedimentos seguros de armazenamento de dados sensíveis. Fluxos automatizados de processamento de dados foram estruturados a partir da transferência direta dos instrumentos de coleta para os servidores de armazenamento, contribuindo para a adoção de boas práticas no manejo e proteção de dados sensíveis.

Nos casos em que as avaliações identificassem ideação suicida ou agravamento clínico relevante, a equipe assistencial responsável pelo paciente era informada, permitindo o encaminhamento adequado para avaliação clínica e definição da conduta terapêutica mais apropriada.

Os demais estudos que compõem esta tese correspondem a revisões da literatura (revisão sistemática e meta-análise) e ao desenvolvimento de material clínico baseado em evidências para o manejo do comportamento suicida, não envolvendo coleta de dados primários com participantes humanos. Dessa forma, tais estudos não necessitam de aprovação por comitê de ética em pesquisa, de acordo com as normativas vigentes.

Considerações finais

Com esta tese, buscamos contribuir para a compreensão de aspectos relacionados à complexidade clínica em psiquiatria, com foco na comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína e no comportamento suicida. Os achados da revisão sistemática e meta-análise indicam que essa comorbidade é frequente e se caracteriza por um perfil clínico mais grave, incluindo maior carga de sintomas afetivos, maior presença de comorbidades psiquiátricas, maior frequência de comportamentos de risco e de uso de múltiplas substâncias, além de menor adesão ao tratamento. No entanto, a elevada heterogeneidade entre os estudos e limitações metodológicas, como o predomínio de delineamentos transversais e controle insuficiente de fatores de confusão, indicam que esses resultados devem ser interpretados com cautela. Nesse sentido, os achados reforçam a necessidade de estudos mais bem delineados, especialmente com acompanhamento longitudinal, que permitam compreender com maior precisão a evolução clínica desses pacientes.

Em relação ao comportamento suicida, o desenvolvimento e a implementação do estudo multicêntrico nacional RISE permitiram estruturar uma coorte longitudinal em contexto brasileiro, com padronização de procedimentos e coleta de dados em diferentes cenários assistenciais. Os dados descritivos apresentados indicam que o risco suicida se organiza como um gradiente clinicamente coerente, com maior vulnerabilidade psicossocial nos níveis mais elevados de risco, além de evidenciar diferenças entre contextos clínicos e centros de pesquisa. O avanço da coleta, com amostra atualmente em expansão e composta por população clínica de alto risco, fortalece o potencial do estudo para análises futuras mais robustas. Por fim, o desenvolvimento do livro clínico buscou traduzir evidências para uma linguagem acessível ao paciente, oferecendo estratégias práticas e exercícios voltados à identificação, manejo e prevenção do risco suicida no cotidiano.

Em conjunto, os produtos desta tese fornecem uma base para futuras investigações, tanto no estudo da comorbidade entre transtorno bipolar e transtorno por uso de cocaína, quanto na compreensão do comportamento suicida, especialmente a partir da integração de dimensões clínicas, sociais e contextuais.

Referências

1. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Psychiatry*. 2022;9(2):137-50.
2. Martinek T, Jarczok M, Rottler E, Hartmann A, Zeeck A, Weiß H, von Wietersheim J. Typical disease courses of patients with unipolar depressive disorder after in-patient treatments: results of a cluster analysis of the INDDEP project. *Front Psychiatry*. 2023;14:1081474.
3. Krebs MD, Themudo GE, Benros ME, Mors O, Børghlum AD, Hougaard D, Thompson WK. Associations between patterns in comorbid diagnostic trajectories of individuals with schizophrenia and etiological factors. *Nat Commun*. 2021;12(1):6617.
4. Passos IC, Mwangi B, Vieta E, Berk M, Kapczinski F. Areas of controversy in neuroprogression in bipolar disorder. *Acta Psychiatr Scand*. 2016;134(2):91-103.
5. Messer T, Lammers G, Müller-Siecheneder F, Schmidt RF, Latifi S. Substance abuse in patients with bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. *Psychiatry Res*. 2017;253:338-50.
6. Anona A, et al. Co-occurrence of bipolar disorder and personality disorders in the United States: prevalence, suicidality, and the impact of substance abuse. *J Affect Disord*. 2024;350:123-31.
7. Gnielka V, et al. Perinatal risk factors for the onset of bipolar disorder in young adulthood: a 22-year birth cohort. *Acta Psychiatr Scand*. 2024;149(3):210-20.
8. Oliveira Alves FJ, Fialho E, Paiva de Araújo JA, Naslund JA, Barreto ML, Patel V, Machado DB. The rising trends of self-harm in Brazil: an ecological analysis of notifications, hospitalisations, and mortality between 2011 and 2022. *Lancet Reg Health Am*. 2024;31:100691.
9. World Health Organization. *Suicide worldwide in 2021: global health estimates*. Geneva: World Health Organization; 2025.
10. Grant BF, Saha TD, Ruan WJ, Goldstein RB, Chou SP, Jung J, et al. Epidemiology of DSM-5 drug use disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions-III. *JAMA Psychiatry*. 2016;73(1):39-47.
11. Musliner KL, Munk-Olsen T, Laursen TM, Eaton WW, Zandi PP, Mortensen PB. Heterogeneity in 10-year course trajectories of moderate to severe major depressive disorder: a Danish national register-based study. *JAMA Psychiatry*. 2016;73(4):346-53.
12. Plana-Ripoll O, et al. A comprehensive analysis of mortality-related health metrics associated with mental disorders: a nationwide, register-based cohort study. *Lancet*. 2019;394(10211):1827-35.
13. Hunt GE, Malhi GS, Cleary M, Lai HM, Sitharthan T. Comorbidity of bipolar and substance use disorders in national surveys of general populations, 1990-2015: systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*. 2016;206:321-30.
14. United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2025*. Vienna: United Nations; 2025.
15. Anugwom GO, Oladunjoye AO, Basiru TO, Osa E, Otuada D, Olateju V, et al. Does cocaine use increase medication noncompliance in bipolar disorders? A United States nationwide inpatient cross-sectional study. *Cureus*. 2021;13(7):e16696.

16. Jawad I, Watson S, Haddad PM, Talbot PS, McAllister-Williams RH. Medication nonadherence in bipolar disorder: a narrative review. *Ther Adv Psychopharmacol*. 2018;8(12):349-63.
17. Roza TH, Marchionatti LE, Gosmann NP, Magalhães PVS, Kessler FHP, Passos IC, et al. Characteristics of deaths by suicide in postmortem studies in Brazil: a systematic review and meta-analysis. *Suicide Life Threat Behav*. 2023.
18. Turecki G, Brent DA, Gunnell D, O'Connor RC, Oquendo MA, Pirkis J, Stanley BH. Suicide and suicide risk. *Nat Rev Dis Primers*. 2019;5(1):74.
19. Lund C, Brooke-Sumner C, Baingana F, Baron EC, Breuer E, Chandra P, Haushofer J, Herrman H, Jordans M, Kieling C, Medina-Mora ME, Morgan E, Omigbodun O, Tol W, Patel V, Saxena S. Social determinants of mental disorders and the Sustainable Development Goals: a systematic review of reviews. *Lancet Psychiatry*. 2018;5(4):357-69.
20. Aguiar KR, Zimmer C, Kampmann L, Caobelli ACSL, Chagas V, Jansen K, et al. Prevalence and clinical correlates of cocaine use disorder among patients diagnosed with bipolar disorder: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Neurosci Biobehav Rev*. 2026;106626. doi:10.1016/j.neubiorev.2026.106626.

ANEXO

Produção Científica

Para além dos trabalhos que compõem esta tese, foram conduzidas investigações adicionais predominantemente no campo dos transtornos de humor, dos transtornos por uso de substâncias e do comportamento suicida, resultando em artigos e capítulos de livro publicados em âmbito nacional e internacional, com participação em diferentes níveis de autoria. Essas produções são apresentadas a seguir.

Produção Internacional

Artigos científicos

- Jorge, A. C. R., Montezano, B. B., de Aguiar, K. R., et al. (2024). *Early exposure to cannabis and bipolar disorder incidence: Findings from a 22-year birth cohort study in Brazil*. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 149(4), 340–349. <https://doi.org/10.1111/acps.13670>
(Co-primeira autoria)

Preprints

- Montezano, B. B., Gnielka, V., Shintani, A. O., de Aguiar, K. R., Roza, T. H., de Azevedo Cardoso, T., et al. (2023). Predicting bipolar disorder incidence in young adults using gradient boosting: a 5-year follow-up study. medRxiv. <https://doi.org/10.1101/2023.03.31.22282507>
(Coautoria)

Capítulos de livro

- de Aguiar, K. R., Zimmer, C., Gnielka, V., & Watts, D. (2025). *The Impact of Substance Use in Latent Bipolar Disorder*. In *Latent Bipolar Disorder* (pp. 187–200). Cham: Springer Nature Switzerland.
(Primeira autora)
- Passos, I. C., et al. (2025). *Historical Roots of Bipolar Disorder*. In: Passos, I. C., Berk, M., Kapczinski, F. (eds) *Bipolar Disorder*. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-85519-1_1

(Coautoria)

- Gnielka, V., de Aguiar, K. R., Ritter, A. C., de Borba Telles, B., Saviatto, N. G., Passos, I. C. (2025). *Epidemiology*. In: Passos, I. C., Berk, M., Kapczinski, F. (eds) *Bipolar Disorder*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-85519-1_3

(Coautoria)

Produção Nacional

Artigos científicos

- Bebber, J. C., Braga Montezano, B., de Souza Vivan, A., Antonelli-Salgado, T., Aguiar, K. R. D., Zimmerman, A., et al. (2025). *Digital interventions for depressive symptoms: a randomized clinical trial. Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, 47, e20241006.
(Coautoria)
- Velda, G. W., Seoane, G. R., Ezequiel, G. R., Ferreira, C. M., de Figueiredo, V. L. M., Meyer, T. D. S., et al. (2024). *Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure for the Brazilian context. Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, 46, e20220573.
(Coautoria)

Capítulos de livro

- de Aguiar, K. R., Marchionatti, L. E., & Passos, I. C. (2023). *Investigação laboratorial: o papel da neuroimagem e da neuropsicologia*. In: Scippa, Â. M. A., & Kapczinski, F. (eds) *Transtorno bipolar: diagnóstico e tratamento*. São Paulo: Atheneu.
(Primeira autora)
- de Aguiar, K. R., Zimmer, C., Pulice, R. F., Caobelli, A. C. S. L., & Passos, I. C. (2023). *Uso de aplicativos no manejo do paciente com transtorno bipolar*. In: Passos, I. C., & Gallois, C. B. (eds) *Psiquiatria digital*. Porto Alegre: Artmed.
(Primeira autora)
- de Aguiar, K. R., Shintani, A. O., Antonelli-Salgado, T., Roza, T. H., Cardia, I. C., Montezano, B. B., & Passos, I. C. (2023). *Suicídio*. In: Cordioli, A. V., Gallois, C. B., & Passos, I. C. (eds) *Psicofármacos: consulta rápida* (6ª ed.). Porto Alegre: Artmed.
(Coautoria)